EBM 3%問題

EBM「3%問題」— 系統的レビューを使いこなすリテラシー

参考文献

2026-05-27 ・ AI(Claude)作成・主な出典は原典で確認

なぜ今この話？

- 系統的レビューは、2019年時点で1日約80本のペースで公開されている
- うち方法論的に健全で臨床的に有益なものは**約3%**という見積もりがある
- EBMピラミッドの頂点を「疑わずに使っていい」時代は終わった

PART 1

何が起きているのか

PART 1・何が起きているのか

データで見る「SRMA爆発」

1日換算（PubMed収載のSRMA）

約80本

2019年 約29,000本（推計）
2000年は約1,400本

→

方法論的に健全で臨床的に有益

約3%

見積もり（Ioannidis 2016）
≒1日2〜3本（概算）

系統的レビュー全体に対する約3%の幅（模式）



0　　100%

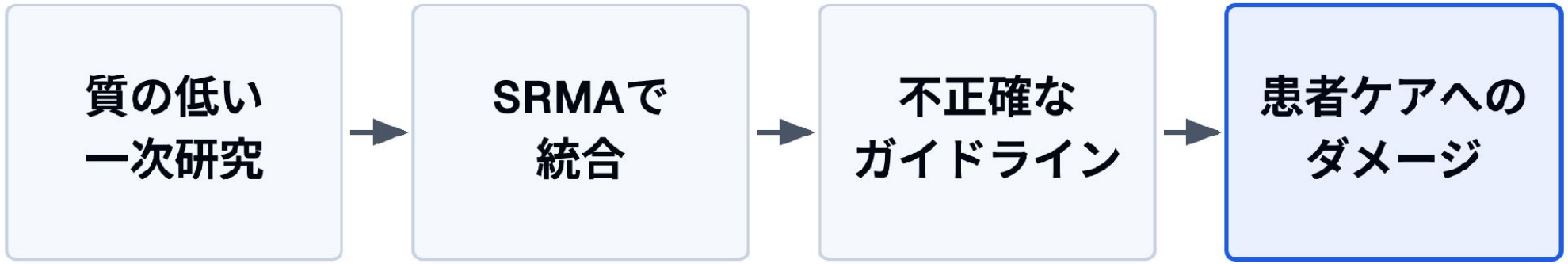
出典: Hoffmann 2021（本数）、Ioannidis 2016（3%）
2026年の編集記事（Rattan 2026）も両者を引用

なぜ量産されるのか

1. **Publish or perish** — 業績評価が論文本数に連動
2. **SRMAは比較的短期間で書ける** — 一次研究より早く量産可能
3. **ジャーナルの受容圧** — インパクトファクターを稼げる

→「量」を求めるインセンティブが「質」を圧迫している

質が低いSRMAの連鎖反応



Garbage in, Garbage out

一次研究の質がSRMAの限界を決める

PART 2

何が問題のSRMAか

よくある方法論的欠陥の例（4点）

1. **サーチ戦略が不完全** — 重要DBを見落とす
2. **選択バイアスの未補正** — 陽性結果だけを集める
3. **一次研究の質評価がない** — RoB未実施
4. **異質性を無視したメタ解析** — 混ぜてはいけないものを混ぜる

AMSTAR-2 で5分チェック

重要項目の例	確認ポイント
プロトコル	レビュー開始前に登録されているか
文献検索	2つ以上のDBを包括的に検索しているか
バイアス評価	個々の研究のRoBを評価しているか
統合方法	メタ解析の方法が適切か（異質性の扱いを含む）

AMSTAR-2は全16項目。うち**重要7項目**に欠陥があるほど、信頼度は「高・中・低・非常に低」の4段階で下がる。上の4つはその抜粋で、全体の評価の代わりにはならない

PART 2・何が問題のSRMAか

RoB(バイアスのリスク)とは

- Risk of Bias = 一次研究の内的妥当性の評価
- ツール: RoB 2 (RCT) / ROBINS-I (観察研究)
- 「全研究が高RoB」→ SRMAの結論は弱い証拠

PART 3

どう使うか

PART 3・どう使うか

実践ステップ：SRMAを読む前に

1. **AMSTAR-2評価** — 高品質か確認（5分）
2. **Forest plot を見る** — 異質性 I^2 は目安（Cochraneは30〜60%で中等度、50〜90%で相当、75%以上で大きいと幅で解釈）
3. **出版バイアス** — Funnel plotの非対称性を確認
4. **一次研究の質** — ほとんど低RoBか

ケースで考える

仮想例（数値は架空）

「高血圧患者にアスピリンを一次予防に使うべきか」

*SRMA: ”有益” → **ただしI²=78%、出版バイアスあり、RoB高研究が60%***

これをガイドラインに使う？ → **慎重に扱う理由になる**

PART 3・どう使うか

ガイドラインを読む目も変わる

- ガイドラインの「A推奨」の根拠SRMAを1本追う
- AMSTAR-2スコアが公開されているか確認する
- 「ガイドラインが多すぎて追えない」の本質: **質のばらつきが大きい**

PART 4

まとめ

持ち帰りの3点

1. **1日約80本、臨床に有益なのは約3%という見積もり** — SRMAは量ではなく質で選ぶ
2. **AMSTAR-2の重要項目** — 5分で当たりをつけられる
3. **Garbage in, Garbage out** — 一次研究の質がSRMAの限界を決める

PART 4・まとめ

明日の外来で使える問い

「このガイドラインの根拠SRMAは、質の評価をしているか？」

この問いを持つだけで、エビデンスとの向き合い方が変わる

PART 4・まとめ

ディスカッション

- あなたが最近参照したSRMAは何でしたか？
- そのSRMAのAMSTAR-2評価を、よければ調べてみませんか
- 「信頼できると思う」根拠は何ですか？